



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RS
PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Pedoman Pelayanan TB Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakannya Pedoman Pelayanan TB Rumah Sakit ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 01 November 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LEMBAR PENGESAHAN

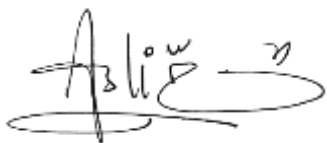
Pedoman Pelayanan Penanggulangan Tuberkolosis
Rumah Sakit Prima Husada

Penanggung Jawab :



(Citra Intan Pratiwi, S.Kep., Ns)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kep.,AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

1. Dr.dr. Aslichah, M.Kep.,AFP
2. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

PENYUSUN :

1. dr. Novita Maulidya Sp.P
2. Citra Intan Pratiwi S.Kep.,Ns

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

TIM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 2

BAB II STANDAR KETENAGAAN..... 4

 2.1.Kualifikasi Sumber Daya Manusia..... 4

 2.2.Distribusi Ketenagaan..... 4

BAB III STANDAR FASILITAS..... 5

 3.1. Denah Ruangan..... 5

 3.2 Standar Fasilitas..... 6

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN..... 7

 4.1 Kemampuan Promosi Kesehatan (Promkes)..... 7

 4.2 Kemampuan Surveilans TB..... 7

 4.3 Kemampuan Pengendalian Faktor Resiko TB..... 7

 4.4 Kemampuan penemuan dan penanganan kasus TB..... 7

 4.5 Kemampuan pemberian kekebalan (imunisasi)..... 7

 4.6 Kemampuan pemberian obat pencegahan (TPT)..... 7

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN PENANGGULANGAN TB..... 8

 5.1 Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan TB..... 8

 5.2 Promosi Kesehatan..... 8

 5.3 Surveilans TB..... 8

 5.4 Pengendalian Faktor Resiko..... 8

 5.5 Penemuan dan Penanganan Kasus TB..... 8

 5.6 Pemberian Kekebalan..... 12

 5.7 Pemberian obat pencegahan..... 12

BAB VI LOGISTIK..... 12

 6.1 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Paket..... 13

 6.2 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Non Paket..... 13

BAB VII KESELAMATAN PASIEN..... 13

 7.1 Pengertian..... 14

 7.2 Tujuan..... 14

 7.3 Tata laksana keselamatan pasien..... 14

BAB VIII KESELAMATAN KERJA	18
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	18
9.1 Pengendalian mutu TB	18
9.2 Menilai Kemajuan atau keberhasilan TB	18
BAB X PANDUAN PRAKTIK KLINIS	19
BAB XI PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pola ketenagaan TIM TB-DOTS Di Rumah Sakit Prima Husada..... 4

Tabel 5.1 Obat Anti Tuberkolosis (OAT)..... 9

Tabel 5.2 Kisaran dosis OAT lini pertama bagi pasien dewasa.....10



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 949.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PENANGGULANGAN TB RUMAH SAKIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional;
- b. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, keselamatan petugas, serta mencegah penularan Tuberkulosis di lingkungan rumah sakit, diperlukan pedoman pelayanan yang terstandar dan terdokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan TB Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. KMK No.HK.01.07-MENKES-350-2017 tth RS dan Balai Kesehatan Layanan Tuberkulosis Resisten Obat;
5. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Kepdirjen Nomor HK.01.07./MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

- (1) Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya;
- (2) Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang



mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis;

- (3) Penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit;
- (4) Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan TB dengan strategi DOTS;
- (2) Direktur Rumah Sakit menetapkan Tim TB/DOTS melalui Surat Keputusan Direktur;
- (3) Tim TB/DOTS memiliki program kerja tahunan, indikator mutu, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program TB;
- (4) Susunan organisasi Tim TB/DOTS sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab program TB;
 - b. Ketua Tim TB/DOTS;
 - c. Dokter pelaksana pelayanan TB;
 - d. Perawat pengelola program TB;
 - e. Petugas laboratorium TB;
 - f. Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
 - g. Petugas pencatatan dan pelaporan;
 - h. Perwakilan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- (5) Tim TB paru Rumah Sakit bekerja sesuai wewenang masing – masing berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3 Tata Hubungan Kerja

- (1) Tim TB bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Direktur Rumah Sakit memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, sarana, prasarana, dan pembiayaan program TB;
- (3) Tim TB menyampaikan laporan kegiatan, capaian indikator, dan hasil monitoring evaluasi secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit;
- (4) Tim TB berkoordinasi dengan unit Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Inap, Laboratorium, Instalasi Farmasi, dan Tim PPI.



BAB III STANDAR FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit menyediakan ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi TB ;
 - a. Area skrining TB;
 - b. Ruang pelayanan rawat jalan TB.;
 - c. Ruang konsultasi dan edukasi pasien TB;
 - d. Ruang pengambilan spesimen dahak;
 - e. Fasilitas laboratorium pemeriksaan TB.;
 - f. Ruang perawatan pasien TB sesuai kemampuan rumah sakit;
 - g. Sarana pencatatan dan pelaporan TB;
 - h. Fasilitas pencegahan dan pengendalian infeksi TB;
- (2) Rumah Sakit memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien tuberkulosis paru dewasa, maka Rumah Sakit harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi TB;
- (3) Rumah sakit menerapkan pengendalian infeksi TB melalui;
 - a. Pengendalian administratif;
 - b. Pengendalian lingkungan;
 - c. Penggunaan alat pelindung diri;
- (2) Rumah sakit wajib menyediakan peralatan yang mendukung pelayanan TB sesuai kemampuan pelayanan, meliputi:
 - a. Peralatan pemeriksaan klinis;
 - b. Peralatan laboratorium TB;
 - c. Peralatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan;
 - d. Peralatan pendukung edukasi pasien.;
 - e. Peralatan pengendalian infeksi.

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN PENANGGULANGAN TB

Pasal 5

Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan TB

- (1) Rumah sakit menerapkan regulasi tentang pelaksanaan penanggulangan tuberkolosis di Rumah Sakit;
- (2) Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Promosi kesehatan;
 - b. Surveilans TB;
 - c. Pengendalian faktor resiko;
 - d. Penemuan dan penanganan kasus TB;
 - e. Pemberian kekebalan;
 - f. Pemberian obat pencegahan;
- (3) Direktur menetapkan Tim TB paru rumah sakit beserta program kerjanya.



Pasal 6
Promosi Kesehatan

- (1) Promosi Kesehatan dalam penanggulangan TB ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program;
 - c. Memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di Rumah sakit;
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan Rumah sakit;
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.

Pasal 7
Surveilans TB

- (1) Surveilans TB Rumah sakit melakukan pemantauan dan analisis secara terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien;
- (2) Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian;
- (3) Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program penanggulangan TB;
- (4) Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resisten obat.

Pasal 8
Pengendalian Faktor Resiko

- (1) Pengendalian faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB;
- (2) Pengendalian faktor risiko TB dilakukan dengan cara:
 - a. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Membudayakan perilaku etika berbatuk;
 - c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan rumah sesuai dengan standar;
 - d. Peningkatan daya tahan tubuh;
 - e. Penanganan penyakit penyerta TB;
 - f. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan.



Pasal 9

Penemuan dan Penanganan Kasus TB

- (1) Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif;
- (2) Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - b. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko;
 - c. Skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- (4) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB;
- (5) Penanganan kasus dalam penanggulangan TB dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan pengobatan pasien;
- (6) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengobatan dan penanganan efek samping di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. Pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan.

Pasal 10

Pemberian Kekebalan

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka penanggulangan TB dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TB;
- (2) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

Pemberian Obat Pencegahan

- (1) Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada :
 - a. Anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif;
 - b. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnos TB;
 - c. Populasi tertentu lainnya.

BAB V

PANDUAN PRAKTIK KLINIS TB

Pasal 12

Panduan Pratik Klinis TB

- (1) Rumah Sakit menetapkan kepatuhan staf medis terhadap panduan praktik klinis TB;



- (2) Rumah Sakit merencanakan dan mengadakan penyediaan obat anti TB;
- (3) Rumah Sakit melaksanakan pelayanan TB MDR (bagi rumah sakit rujukan TB MDR) ;
- (4) Rumah Sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus TB paru sesuai ketentuan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1167.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2020 tentang pedoman pelayanan penanggulangan TB dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur RS Prima Husada

Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 949.3/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN
PENANGGULANGAN TUBERKOLOSIS

PEDOMAN PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Indonesia termasuk negara dengan beban TB tinggi di dunia berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO). Tingginya angka insiden, prevalensi, serta kematian akibat TB menuntut adanya pelayanan yang komprehensif, terstandar, dan berkesinambungan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit.

Rumah sakit memiliki peran strategis dalam penanggulangan TB, baik dalam aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain sebagai tempat diagnosis dan pengobatan kasus TB sensitif obat (SO) maupun TB resistan obat (RO), rumah sakit juga berperan dalam penanganan kasus dengan komplikasi, komorbid, dan kondisi khusus (TB pada anak, TB-HIV, TB dengan diabetes melitus, dan lain-lain).

Pelayanan TB di rumah sakit harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional penanggulangan TB yang mengacu pada regulasi Kementerian Kesehatan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (atau regulasi terbaru yang berlaku), serta kebijakan program nasional TB. Selain itu, dalam rangka pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien, penyelenggaraan pelayanan TB juga harus memenuhi standar akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), khususnya pada elemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Program Nasional, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), serta Pelayanan Asuhan Pasien (PAP).

Standar akreditasi mensyaratkan bahwa rumah sakit wajib mendukung program nasional, termasuk program penanggulangan TB, melalui:

1. Penemuan dan penanganan kasus sesuai standar.
2. Penerapan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse).
3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB.
4. Pencatatan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi dengan program nasional (SITB).
5. Monitoring dan evaluasi capaian indikator program.

Risiko penularan TB di lingkungan rumah sakit juga menjadi perhatian penting karena potensi transmisi nosokomial kepada pasien lain, pengunjung, maupun tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman internal yang mengatur tata laksana pelayanan TB

secara menyeluruh, mulai dari skrining, diagnosis, terapi, rujukan, hingga pelaporan, termasuk penguatan aspek keselamatan pasien dan keselamatan kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pelayanan TB yang sesuai dengan standar nasional, regulasi Kementerian Kesehatan, dan standar akreditasi rumah sakit, guna menjamin mutu layanan, keselamatan pasien, keselamatan petugas, serta mendukung pencapaian target eliminasi TB di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan Tuberkulosis (TB). Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan TB di rumah sakit dilaksanakan dengan standar yang sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan dan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku, guna mencapai pengendalian TB yang efektif, efisien, dan berkualitas.

2. Tujuan Umum

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk pasien Tuberkulosis (TB) dengan memberikan panduan yang jelas dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari skrining, diagnosis, pengobatan, hingga pencegahan penularan dan pemantauan pasca pengobatan
- b. Menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan selama proses pelayanan, dengan menerapkan standar pengendalian infeksi yang tepat di lingkungan rumah sakit, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akreditasi rumah sakit.
- c. Mendukung pencapaian target eliminasi Tuberkulosis (TB) pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan global yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan mempercepat penemuan kasus dan meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TB.

3. Tujuan Khusus

- a. Menyusun prosedur pelayanan yang terstandarisasi bagi setiap aspek pelayanan TB, mulai dari penemuan kasus, diagnosis, pengobatan, hingga rujukan yang sesuai dengan pedoman nasional dan standar akreditasi rumah sakit.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit dalam penanggulangan TB, dengan memperkuat pelatihan dan edukasi terkait manajemen kasus TB serta pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit.
- c. Mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus TB dengan menggunakan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) yang terintegrasi, guna memastikan pelaporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar nasional.
- d. Meminimalisir transmisi nosokomial TB di rumah sakit dengan penerapan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), seperti skrining yang ketat, penggunaan masker medis dan N95, serta pengaturan ruang isolasi yang sesuai.
- e. Menjamin pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pengobatan dan status pasien TB, guna memastikan keberhasilan pengobatan yang optimal serta mencegah munculnya kasus baru atau TB resistan obat (TB-RO).
- f. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara rumah sakit dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, Dinas Kesehatan, dan program

penanggulangan TB di tingkat kabupaten/kota, dalam rangka menciptakan jaringan pelayanan yang BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1.Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan TB DOTS Di Rumah Sakit Prima Husada dipimpin oleh Ketua Tim DOTS. Distribusi ketenagaan TB DOTS disesuaikan dengan kualifikasi dan beban kerja yang ada. Untuk distribusi ketenagaan TB DOTS disebutkan dalam tabel ,sesuai dengan tugas masing – masing.

Tabel 2. 1 Kualifikasi TIM TB-DOTS Di Rumah Sakit Prima Husada.

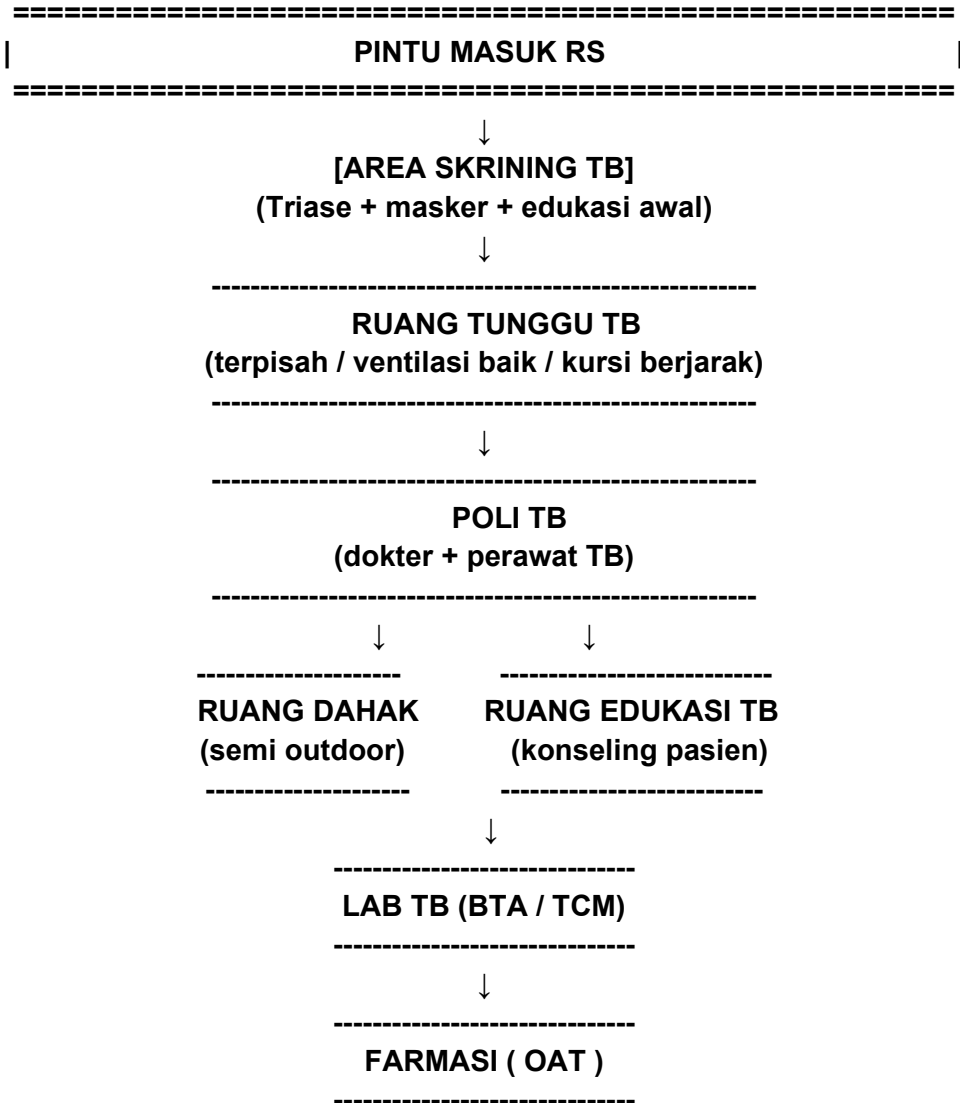
Jabatan	Pendi di-kan	Sertifikasi			
	Stand ar	ACLS (wajib)	PPI (wajib)	TB DOTS (wajib)	MKE (wajib)
Ketua Tim TB DOTS : dr. Novita Maulidyah, Sp.P	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Koordinator Program dan sekertaris TB DOTS : Irawati S.Kep.,Ns	S1	Belum dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Anggota Tim TB					
Citra Intan Pratiwi S.Kep.,Ns	S1	Belum dilakuakan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Sudah dilakukan
Nikmatul khoriah A.Md.Kes	D3	Belum dilakuakan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Apt.Rohmah Madya Ayu Fitriana S.Farm	D3	Belum dilakuakan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Novita Febri Setiyani S.Kep., Ns	S1	Belum dilakuakan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan	Sudah dilakukan

2.2.Distribusi Ketenagaan

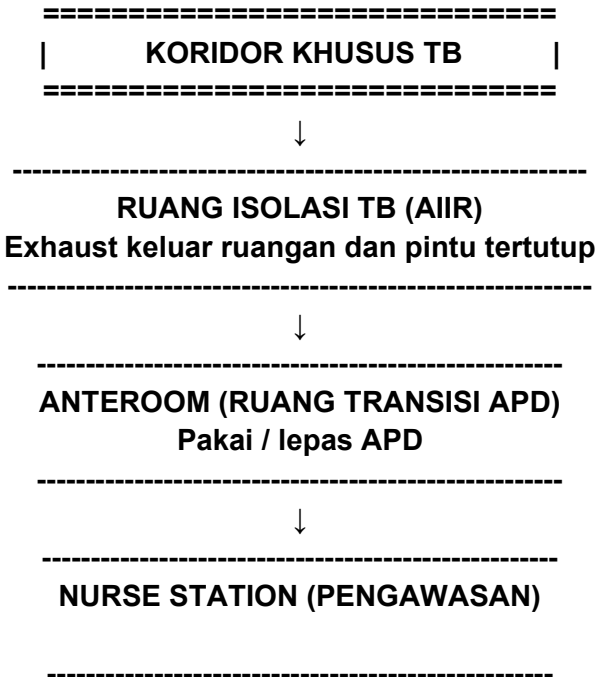
Petugas TB DOTS berjumlah 6 orang dan sesuai dengan struktur organisasi TIM TB DOTS terbagi menjadi Ketua Tim TB DOTS, sekretaris, koordinator rawat inap, koordinator rawat jalan, koordinator farmasi dan koordinator laboratorium.

BAB III
STANDAR FASILITAS

- 3.1. Denah Ruangan
1. Denah Rawat Jalan Pelayanan TB



2. Denah Rawat Inap (Isolasi TB)



3.2 Standar Fasilitas

1. Ruang wajib

- a. Mempunyai ruangan untuk skrining TB;
- b. Mempunyai poliklinik TB (rawat jalan);
 - 1) Area terpisah dari poli umum.
 - 2) Mempunyai ventilasi yang baik
 - 3) Jalur pasien TB jelas (tidak bercampur).
- c. Terdapat ruang pengambilan dahak yang berada di depan poliklinik TB;
 - 1) Ruangan terpisah dari ruang tunggu.
 - 2) Mempunyai ventilasi yang baik (alami atau exhaust fan).
 - 3) Ruangan terbuka / semi terbuka.
 - 4) Tersedia tempat cuci tangan.
- d. Laboratorium yang terdesia mikroskop dan tes TCM;
- e. Adanya ruang isolasi TB (rawat inap);
 - 1) Tekanan negatif.
 - 2) Exhaust keluar gedung (tidak resirkulasi).
 - 3) Pintu ruangan selalu tertutup.
 - 4) Terdapat APD bagi tenaga kesehatan (N95).
- f. Farmasi untuk penyimpanan obat TB (OAT).

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

- 4.1 Kemampuan Promosi Kesehatan (Promkes)
 - 1. Edukasi individu dan keluarga;
 - 2. Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - 3. Penyuluhan kelompok dilakukan di ruang tunggu atau poli TB.
- 4.2 Kemampuan Surveilans TB
 - 1. Pengumpulan data;
 - 2. Analisa data;
 - 3. Pelaporan;
 - 4. Monitoring dan evaluasi.
- 4.3 Kemampuan Pengendalian Faktor Resiko TB
 - 1. Pengendalian administratif;
 - 2. Pengendalian lingkungan;
 - 3. Pengendalian perilaku;
 - 4. Skrining berkala.
- 4.4 Kemampuan penemuan dan penanganan kasus TB
 - 1. Penemuan secara pasif dan aktif dilakukan di IGD, rawat jalan dan rawat inap;
 - 2. Pemeriksaan diagnostik berupa dahak (BTA), Tes Cepat Molekuler (TCM), dan pemeriksaan radiologi;
 - 3. Penanganan kasus TB dilakukan penegakan diagnosis serta Rumah Sakit mampu memberikan pengobatan TB khusus :
 - a. TB paru dewasa
 - b. TB anak
 - c. TB ekstra paru
 - d. TB resisten obat (rujukan)
- 4.5 Kemampuan pemberian kekebalan (imunisasi)
 - 1. Pemberian imunisasi BCG
 - 2. Skrining sebelum imunisasi
 - 3. pencatatan dan pelaporan
- 4.6 Kemampuan pemberian obat pencegahan (TPT)

Memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang ditujukan pada anak < 5 tahun dengan kontak TB, kontak erat dengan pasien TB, orang dengan HIV dan pasien dengan imunokompromasi dengan cara :

 - 1. Melakukan skrining sebelum TPT;
 - 2. Memastikan tidak terdapat TB;
 - 3. Pemberian regimen TPT sesuai pedoman nasional;
 - 4. Memonitoring dan evaluasi kepatuhan dan efektivitas terapi;
 - 5. Mendokumentasikan melalui rekam medis.

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN PENANGGULANGAN TB

5.1 Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan TB

Pelaksanaan pelayanan TB dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta terintegrasi dalam Program Nasional TB dan standar akreditasi (Program Nasional, PPI, PAP, PMKP, dan MIRM). Dalam pelaksanaan penanggulangan TB dapat diselenggarakan melalui :

1. Promosi kesehatan;
2. Surveilans TB;
3. Pengendalian faktor resiko;
4. Penemuan dan penanganan kasus TB;
5. Pemberian kekebalan;
6. Pemberian obat pencegahan.

5.2 Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang TB, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan mencegah penularan di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Dalam pemberian promosi kesehatan dilakukan dengan :

1. Memberikan edukasi sejak pasien teridentifikasi suspek TB dengan pemberian materi berupa :
 - a. Pengertian TB.
 - b. Penyebab TB.
 - c. Cara penularan.
 - d. Gejala TB.
 - e. Faktor risiko.
 - f. Kelompok rentan.
2. Memberikan penyuluhan kelompok di ruang tunggu klinik TB tentang :
 - a. Lama pengobatan.
 - b. Kepatuhan minum obat.
 - c. PMO.
 - d. Efek samping OAT.
 - e. Jadwal kontrol.
3. Menyediakan media KIE (poster dan leaflet);
4. Memberikan edukasi terkait etika batuk dan penggunaan masker.

5.3 Surveilans TB

Surveilans dilakukan untuk memantau tren kasus TB dan keberhasilan pengobatan serta mendukung pelaporan nasional. Kegiatan dalam pelaksanaan surveilans TB sebagai berikut :

1. Rumah sakit wajib melaksanakan surveilans TB secara aktif dan pasif.
2. Surveilans dilaksanakan oleh Tim TB DOTS.
3. Data surveilans digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
4. Seluruh kasus TB wajib dicatat dan dilaporkan.
5. Surveilans dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit dan sistem nasional TB.
6. Kerahasiaan data pasien harus dijaga sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Mencatat semua kasus TB dalam register TB;
8. Pelaporan dilakukan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
9. Monitoring dan evaluasi keberhasilan pasien dalam pengobatan TB;
10. Prinsip surveilans :
 - a. Akurat.
 - b. Lengkap.

- c. Tepat waktu.
- d. Berkesinambungan.
- e. Terintegrasi.
- f. Dapat ditindaklanjuti.

5.4 Pengendalian Faktor Resiko

1. Pengendalian administratif dilakukan dengan melakukan skrining pada pasien batuk, pemisahan pasien suspek TB, dan melakukan triase sesuai SPO TB;
2. Pengendalian lingkungan dalam pelaksanaan pelayanan penanggulangan TB berupa tersedianya ventilasi yang memadai (alami/mekanik) , menyediakan ruang isolasi TB dan mengatur alur pasien TB;
3. Pengendalian perilaku yaitu menyediakan masker medis untuk pasien dan pemakaian masker N95 untuk petugas;
4. Melakukan skrining berkala bagi petugas TB;
5. Pasien Diabetes Melitus;
 - a. Skrining gejala TB;
 - b. Edukasi risiko TB;
 - c. Rujukan pemeriksaan bila dicurigai TB;
6. Orang Dengan HIV
 - a. Skrining TB rutin;
 - b. Investigasi kontak;
 - c. TPT sesuai indikasi;
7. Anak Kontak Serumah
 - a. Pelacakan kontak;
 - b. Pemeriksaan TB;
 - c. Pemberian TPT sesuai ketentuan;
8. Tenaga Kesehatan
 - a. Skrining berkala.
 - b. Edukasi TB.
 - c. Pelaporan pajanan TB.
 - d. Pemeriksaan kesehatan berkala.

5.5 Penemuan dan Penanganan Kasus TB

Penemuan kasus TB di Rumah Sakit dilaukan secara pasif dan aktif, terintegasi di seluruh unit pelayanan (IGD, Rawat Jalan, dan Rawat Inap).

1. Melakukan skrining pada kelompok risiko tinggi (pasien dengan suspek TB, kontak erat pasien TB, pasien HIV dan tenaga kesehatan;
2. Pemeriksaan penunjang berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) dan foto Thorax;
3. Penanganan kasus TB dilakukan penegakan diagnosis serta Rumah Sakit mampu memberikan pengobatan TB khusus :

Tabel 5.1 Obat Anti Tuberkolosis (OAT)

Jenis	Sifat	Efek Samping
Isoniazid (H)	Bakterisidal	Neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan fungsi hati, kejang
Rifampisin(R)	Bakterisidal	Flu syndrome, gangguan gastrointestinal, urine berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopeni, demam, skinrash, sesak nafas, anemia hemolitik
Pirazinami d(Z)	Bakterisidal	Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, goutarthritis
Streptomisi n(S)	Bakterisidal	Nyeri ditempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia,agranulositosis, trombositopeni
Etambutol(E)	Bakteriostatik	Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer

a. TB paru dewasa

Pemeriksaan TCM (Test Cepat Molekuler) digunakan untuk mendiagnosa TBC baik Paru maupun Ekstra Paru, baik riwayat pengobatan TBC baru maupun yang memiliki riwayat pengobatan TBC sebelumnya dan semua golongan umur termasuk pada ODHA. Pemeriksaan TCM dilakukan dari spesimen dahak (untuk terduga TBC Paru) dan non dahak (untuk terduga TBC ekstra Paru) yaitu dari cairan Cerebro Spinal, kelenjar limfe dan jaringan). Pemeriksaan TCM digunakan untuk menegaskan diagnosa TB namun untuk follow up menggunakan pemeriksaan BTA (sewaktu – sewaktu, Pagi – sewaktu). Seluruh terduga TBC harus dilakukan pemeriksaan TCM pada fasilitas kesehatan yang saat ini sudah mempunyai alat TCM. Jumlah dahak yang dikumpulkan adalah 2 (dua) dahak yaitu sewaktu – sewaktu, sewaktu – pagi maupun pagi – sewaktu dengan jarak 1 jam dari pengambilan dahak pertama ke pengambilan dahak kedua. Standar kualitas dahak yang digunakan adalah dahak dengan volume 3-5 ml dan mukopurulen. Hasil pemeriksaan TCM terdiri dari MTB Pos Rif resisten, MTB Pos Rif sensitif, MTB Pos Rif Indeterminate, MTB Negatif dan hasil gagal (error, invalid, no result) Beberapa ketentuan terkait hasil pemeriksaan tersebut adalah :

- 1) Pasien dengan hasil MTB Pos, Rif Resisten berdasarkan riwayat pengobatannya terdiri dari :
 - Pasien berasal dari kriteria terduga TBC baru atau tidak ada kontak erat dengan TBC RO harus dilakukan pengulangan TCM sebanyak 1 Kali dan hasil pengulangan yang memberikan hasil MTB Pos yang menjadi acuan.

Tabel 5.2 Kisaran dosis OAT lini pertama bagi pasien dewasa

O A T	Dosis			
	Harian		3 x / Minggu	
	Kisaran dosis (mg/kg BB)	Maksimum (mg)	Kisaran dosis (mg / kg BB)	Maksimum / hari (mg)
Isoniasid	5 (4 – 6)	300	10 (8 – 12)	900
Rifampisin	10 (8 – 12)	600	10 (8 – 12)	600
Pirazinamid	25 (20 – 30)	-	35 (30 – 40)	-
Etambutol	15 (15 – 20)	-	30 (25 – 35)	-
Streptomisin	15 (12 – 18)	-	15 (12 – 18)	1000

- Pasien berasal dari kriteria terduga TBC baru dengan riwayat kontak erat dengan pasien TBC RO atau terduga TBC dengan riwayat pengobatan sebelumnya dinyatakan sebagai pasien TBC Rifampisin resistan dan selanjutnya dilakukan inisiasi pengobatan TBC RO.
 - Pasien berasal dari kriteria terduga TBC ekstra Paru tanpa riwayat pengobatan TBC sebelumnya sebaiknya diulang TCM sebanyak 1 Kali dengan spesimen yang berbeda.Apabila tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengulangan terkait kesulitan mendapatkan spesimen baru,pertimbangkan kondisi klinis pasien.
- 2) Pasien yang terkonfirmasi sebagai pasien TBC Rifampisin resistan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan molekuler (LPA lini dua atau TCM XDR) dan pemeriksaan paket standar uji kepekaan fenotipik.Fasilitas kesehatan akan mengirimkan spesimen dahak dari pasien tersebut ke laboratorium rujukan sesuai jejaring rujukan yang berlaku.Hasil pemeriksaan ini akan menentukan paduan pengobatan TBC RO yang akan diberikan terhadap pasien.
- 3) Pasien dengan hasil MTB Pos Rif sensitif berdasarkan riwayat pengobanatnnya terdiri dari :
- Pasien berasal dari kriteria terduga TBC baru akan dilakukan inisiasi pengobatan OAT Kategori 1.
Kategori 1 : 2(HRZE) / 4(HR)3
 - Pasien berasal dari kriteria terduga TBC dengan riwayat pengobatan sebelumnya (kambuh, gagal, loss to follow up,tidak konversi) akan dilanjutkan dengan pemeriksaan uji kepekaan terhadap INH. Inisiasi atau melanjutkan pengobatan dengan OAT Kategori 1 dilakukan sambil menunggu hasil uji kepekaan terhadap INH. Apabila hasil uji kepekaan menunjukan INH resistan akan diberikan paduan pengobatan TBC Monoresistan INH.
- 4) Pasien berasal dari kriteria terduga TBC dengan riwayat pengobatan sebelumnya (kambuh, gagal, loss to follow up, tidak

konversi) akan dilanjutkan dengan pemeriksaan uji kepekaan terhadap INH. Inisiasi atau melanjutkan pengobatan dengan OAT Kategori 1 dilakukan sambil menunggu hasil uji kepekaan terhadap INH. Apabila hasil uji kepekaan menunjukkan INH resistan akan diberikan paduan pengobatan TBC Monoresistan INH.

- 5) Pasien dengan hasil TCM gagal (invalid,error,no result) akan dilakukan pengulangan oleh laboratorium TCM untuk memastikan pasien Positif atau negatif TBC dan mengetahui status resistansi terhadap rifampisin.Gunakan sisa sampel jika masih tersedia.Pada kondisi sampel kurang dari 2 ml, gunakan dahak kedua. Apabila dahak kedua tidak tersedia kumpulkan dahak baru dengan kualitas baik yaitu 3-5 ml dan mukopurulen.
- 6) Pasien dengan MTB negatif dapat dilakukan pemeriksaan foto thorak dan atau pemberian antibiotik spektrum luas.Pasien tersebut dapat didiagnosis sebagai TBC klinis sesuai pertimbangan klinisi.
- 7) Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum / tidak mempunyai TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasilitas pelayanan kesehatan TCM. Merujuk dahak lebih direkomendasikan dibanding merujuk terduga TBC terkait alasan pengendalian Infeksi. Rumah Sakit Prima Husada untuk pemeriksaan TCM dengan cara merujuk terduga atau dahak terduga TBC ke UPK lain di wilayah Kabupaten Pasuruan.

b. TB anak

Untuk pasien anak yang dapat mengeluarkan dahak , penegakan diagnosa TB paru tetap menggunakan pemeriksaan dahak TCM (Tes Cepat Molekuler). Untuk anak yang tidak dapat menegluarkan dahak , , diagnosa TB ditegakkan dengan menggunakan system scoring. Diagnosa TB ditegakkan jika nilai scoring ≥ 6.

Tabel 5.3 OAT anak yang biasa dipakai dosisnya.

Nama Obat	Dosis harian (mg/kgBB/hari)	Dosis Maksimal (mg/hari)	Efek Samping
Isoniazid (H)	10(7-15)	300	Hepatitis, neuritis, perifer, hipersensitivitas
Rifampisin(R)	15(10-20)	600	Gastrointestinal, reaksi kulit, hepatitis, trombositopenia, peni ngkatan enzim hati, cairan tubuh berwarna orange kemerahan
Pirazinamid(P)	35(30-40)	-	Toksisitas hepar,artralgia,gastrointestinal
Etambutol(E)	20(15-25)	-	Neuritis optik, ketajaman mata berkurang, buta warna merah hijau hipersensitivitas, gastrointestinal.
Streptomisin(S)	15-40	1000	Ototoksik, nefrotoksik

d. TB ekstra paru

Pemeriksaan yang dipakai untuk menegakkan TB ekstra paru menggunakan TCM yaitu dari cairan serebro spinal, kelenjar limfe dan jaringan).

e. TB resisten obat (rujukan)

- 1) Rujukan Awal : Rumah Sakit Prima Huasada hanya menegakkan diagnosa TB, seluruh pengobatan dilakukan di UPK lain mulai dari awal;
- 2) Rujukan Tengah Pengobatan : Rumah Sakit Prima Huasada menegakkan diagnose TB, meregister sebagai pasien TB di Rumah Sakit Prima Huasada, memulai pengobatan , dan ditengah pengobatan memindah pasien TB ke UPK lain.

Ruang instalasi Rawat Inap atau poliklinik yang akan merujuk pasien TB harus berkoordinasi dengan unit DOTS melalui koordinator rawat jalan. Form yang dipakai untuk merujuk pasien TB adalah TB09, dan data pasien yang dirujuk harus dicatat di buku rujukan TB.

5.6 Pemberian Kekebalan

Memberikan imunisasi BCG pada bayi sesuai jadwal nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu diberikan pada usia 0–1 bulan atau sebelum bayi berusia 3 bulan.

1. Melakukan skrining sebelum imunisasi;
 - a. Memastikan bayi dalam kondisi sehat.
 - b. Tidak terdapat kontraindikasi imunisasi BCG.
 - c. Tidak terdapat tanda/gejala tuberkulosis aktif.
2. Mengedukasi orang tua tentang imunisasi, meliputi ;
 - a. Manfaat imunisasi BCG dalam mencegah TB berat pada anak.
 - b. Reaksi yang mungkin timbul pasca imunisasi.
 - c. Pentingnya melengkapi imunisasi dasar.
3. Mencatat dalam sistem imunisasi nasional.

5.7 Pemberian obat pencegahan

Memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang ditujukan pada anak < 5 tahun dengan kontak TB, kontak erat dengan pasien TB, orang dengan HIV dan pasien dengan imunokompromasi dengan cara :

1. Melakukan skrining gejala aktif TB;
 - a. Anamnesis gejala (batuk $\geq$ 2 minggu, demam, penurunan berat badan, keringat malam).
 - b. Dilakukan pemeriksaan penunjang (rontgen thoraks dan/atau Tes Cepat Molekuler bila diindikasikan), apabila ditemukan TB aktif, maka pasien diberikan pengobatan TB dan tidak diberikan TPT.
2. Memastikan tidak terdapat TB;
 - a. Tidak ditemukan tanda gejala TB aktif.
 - b. Tidak terdapat kontraindikasi terhadap obat anti tuberkulosis.
 - c. Pasien / keluarga menyetujui terapi.
3. Memberikan regimen TPT sesuai pedoman nasional;
 - a. Isoniazid (INH) selama 6 bulan (6H) atau 9 bulan.
 - b. Kombinasi Isoniazid dan Rifampisin selama 3 bulan (3HR).
 - c. Kombinasi Isoniazid dan Rifapentine selama 3 bulan (3HP).
4. Monitoring efek samping dan kepatuhan pengobatan meliputi gejala, efek samping yang ditimbulkan serta kepatuhan pasien.
5. Mendokumentasikan melalui rekam medis dan melaporkan melalui sistem nasional.

BAB VI

LOGISTIK

Pengadaan logistik untuk pelayanan DOTS dilakukan dengan mengajukan permintaan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sesuai kebutuhan.

6.1 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Paket

Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan OAT paket merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada dibawah Koordinator Farmasi DOTS. OAT paket terdiri dari :

1. OAT KDT kategori 1
2. OAT KDT kategori 2
3. OAT Kombipak anak
4. OAT Kombipak kategori 1

6.2 Obat Anti Tuberculosis (OAT) Non Paket

Instalasi Farmasi juga menyediakan OAT non paket (generik atau paten), yang pengadaannya sesuai dengan belanja farmasi. Koordinator Farmasi mengajukan pemesanan OAT paket kepada Dinas Kesehatan Kabupaten pasuruan melalui Koordinator Rawat Jalan atau Koordinator DOTS.

1. Logistik Laboratorium

Pengadaan dan pengelolaan logistik Laboratorium berkaitan dengan DOTS (pemeriksaan BTA SPS) merupakan tanggung jawab Instalasi Laboratorium di bawah Koordinator laboratorium. Kebutuhan logistik laboratorium terkait DOTS terdiri dari :

- a. Objek glass
- b. Cat *Ziehl Neelsosn*
- c. Pot sputum
- d. Box penyimpanan objek glass
- e. TB 04
- d. TB 06

Catatan : Pengadaan oleh Rumah Sakit Pruma Husaha Sukorejo.

2. Logistik Dokumentasi

Logistik dokumentasi DOTS berkaitan dengan pencatatan pasien TB, meliputi:

- a. TB 01 (status pasien TB)
- b. TB 02 (kartu kontrol pasien)
- c. TB 04 (data pemeriksaan BTA – laboratorium)B 03 (buku besar DOTS rumah sakit)
- d. TB 05 (formulir permintaan pemeriksaan BTA)
- e. TB 06 (buku data suspek TB)
- f. TB 09 (form rujukan)

Catatan : Koordinator laboratorium mengajukan pemesanan logistik laboratorium kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 Identifikasi pasien

1. Setiap pasien TB wajib diidentifikasi dengan benar menggunakan minimal dua identitas.
2. Identitas yang digunakan adalah:
 - a. Nama lengkap pasien.
 - b. Tanggal lahir atau umur.
 - c. Nomor Rekam Medis (NRM).
3. Nomor kamar, nomor tempat tidur, atau lokasi perawatan tidak boleh digunakan sebagai identitas pasien.
4. Identifikasi dilakukan pada setiap kontak pelayanan.
5. Seluruh petugas yang memberikan pelayanan TB bertanggung jawab melakukan identifikasi pasien.
6. Identifikasi pasien harus didokumentasikan dalam rekam medis.

7.2 Peningkatan Komunikasi Efektif

Menjamin ketepatan komunikasi antar tenaga kesehatan dalam pelayanan TB.

- a. Hasil kritis pemeriksaan TB harus segera disampaikan kepada dokter penanggung jawab. Contohnya : TCM positif Rif Sen, BTA positif tinggi dan Kultur positif. Menggunakan prosedur "SBAR" Write, Read dan Repeat Back (Reconfirm).

7.3 Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai

Obat-obatan yang perlu diwaspadai (high alert medication) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius (sentinel event), dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome), Untuk OAT yang waktu penggunaannya jangka panjang, harus diwaspadai juga masa / tanggal kadaluarsanya.

7.4 Kepastian Tepat Pasien, Tepat Prosedur, dan Tepat Pemeriksaan

Obat-obatan yang perlu diwaspadai (high alert medication) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius (sentinel event), dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome), Untuk OAT yang waktu penggunaannya jangka panjang, harus diwaspadai juga masa / tanggal kadaluarsanya.

7.5 Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan. Infeksi biasa dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah, pneumonia yang sering berhubungan dengan ventilasi mekanis. Pokok eliminasi infeksi ini maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan (hand hygiene) yang tepat.

7.6 Pengurangan Risiko Cedera Akibat Jatuh

Pengurangan pengalaman pasien yang tidak direncanakan untuk terjadinya jatuh. Suatu kejadian jatuh yang tidak disengaja pada seseorang pada saat istirahat yang dapat dilihat / dirasakan , atau kejadian jatuh yang tidak dapat dilihat karena suatu kondisi tertentu seperti stroke, pingsan, dan lainnya. Untuk pasien-pasien TB yang rawat inap, dikaji pula risiko jatuhnya. Apabila termasuk beresiko pasien tersebut dipasang gelang kuning.

Dalam melaksanakan keselamatan pasien standar keselamatan pasien harus diterapkan. Standar tersebut sebagai berikut :

- a. Hak pasien.
- b. Mendidik pasien dan keluarga.
- c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.
- d. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatann pasien.
- e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien.
- f. Mendidik karyawan tentang keselamatan pasien,
- g. Komunikasi yang merupakan kunci bagi karyawan untuk mencapai keselamatan pasien.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

8.1 Keselamatan Kerja

Undang – undang No.36 tahun 2009 pasal 164 ayat 1 menyatakan bahwa Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Rumah sakit adalah tempat kerja yang termasuk dalam kategori disebut diatas, berarti wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di tim pendidikan pasien dan keluarga bertujuan melindungi karyawan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan didalam dan diluar rumah sakit.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa : Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini yang dimaksud pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia.

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap pekerja dalam hal ini TIM TB-DOTS dan perlindungan terhadap Rumah Sakit . Pegawai adalah bagian integral dari rumah sakit. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai dan meningkatkan produktivitas rumah sakit. Undang- undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin :

1. Agar pegawai dan setiap orang yang berada ditempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat.
2. Agar faktor – faktor produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien
3. Agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
4. Faktor - faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat digolongkan pada tiga kelompok,yaitu :
 - a. Kondisi dan lingkungan kerja
 - b. Kesadaran dan kualitas pekerja
 - c. Peranan dan kualitas manajemen
5. Dalam kaitannya kondisi dan lingkungan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila :
 - a. Peralatan tidak memenuhi kualitas
 - b. Alat – alat produksi tidak disusun secara teratur menurut tahapan proses produksi.
 - c. Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai , ruangan terlalu panas atau terlalu dingin.
 - d. Tidak tersedia alat – alat penagaman.
 - e. Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai , ruangan terlalu panas atau terlalu dingin.
6. Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan perugas kesehatan
 - a. Petugas kesehatan yang merawat pasien TB harus mendapatkan pelatihan / sosialisasi mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protocol.
 - b. Petugas yang terlihat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.
 - c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernafasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.

7. Petunjuk pencegahan infeksi untuk petugas kesehatan

- a. Untuk mencegah transmisi penyakit menular dalam tatanan pelayanan kesehatan, petugas harus menggunakan APD yang sesuai untuk kewaspadaan standard an kewaspadaan isolasi (berdasarkan penularan kontak, droplet, atau udara) sesuai dengan penyebaran penyakit. APD untuk pelayanan pasien TB adalah masker, juga baju kerja serta sarung tangan untuk petugas laboratorium
- b. Semua petugas kesehatan harus mendapatkan pelatihan / sosialisasi tentang gejala TB
- c. Semua petugas kesehatan dengan gejala mencurigakan TB dievaluasi untuk memastikan langsung dengan pasien, terutama mereka yang bertugas di instalasi perawatan intensif (IPI), ruang rawat anak, dan ruang bayi.
- d. Jika petugas kesehatan mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu, cek BTA SPS.
- e. Pasien TB BTA positif harus menggunakan masker jika berada di ruang tertutup dan bersama orang lain.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu pelayanan Tuberkulosis (TB) merupakan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menjamin bahwa pelayanan TB di rumah sakit dilaksanakan sesuai standar, aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

9.1 Pengendalian mutu TB

Pimpinan Rumah Sakit harus melaksanakan evaluasi pelayanan dan pengendalian mutu TB.

9.2 Menilai Kemajuan atau keberhasilan TB

Untuk menilai kemajuan atau keberhasilan pengendalian TB, digunakan beberapa indikator selain indikator mutu diatas, sebagai berikut :

1. Angka ketidakpatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit;
2. Kejadian tidak terpantaunya pasien TB oleh perawat pelaksana;
3. Angka keberhasilan pengobatan TSR, target > 90%;
4. Waktu dari skrining ke diagnosis (hari);
5. Waktu mulai pengobatan setelah diagnosis;
6. Kelengkapan pencatatan dan pelaporan (SITB).

BAB X

PANDUAN PRAKTIK KLINIS TB

- 10.1 Rumah Sakit menetapkan kepatuhan staf medis terhadap panduan praktik klinis TB
Rumah sakit menetapkan kebijakan bahwa seluruh staf medis yang terlibat dalam pelayanan pasien TB wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis TB yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan rumah sakit untuk memastikan kepatuhan staf medis meliputi :
1. Rumah sakit menetapkan kebijakan terkait penerapan Panduan Praktik Klinis TB (PPK) sebagai acuan dalam pelayanan medis;
 2. Rumah sakit melakukan sosialisasi secara berkala kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai pedoman penatalaksanaan TB;
 3. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan TB mendapatkan pelatihan mengenai diagnosis, pengobatan, serta pencegahan penularan TB;
 4. rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) melalui audit medis, telaah rekam medis, dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan;
 5. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa pelayanan TB telah sesuai dengan standar yang berlaku;
- 10.2 Rumah Sakit merencanakan dan mengadakan penyediaan obat anti TB (OAT)
Rumah sakit wajib merencanakan dan menyediakan obat anti tuberkulosis (OAT) secara memadai untuk menjamin kelangsungan pengobatan pasien TB. Perencanaan dan penyediaan obat dilakukan melalui :
1. Perencanaan kebutuhan OAT dilakukan secara berkala berdasarkan jumlah kasus TB yang ditangani, penggunaan obat sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan obat pada periode berikutnya;
 2. Pengadaan obat anti TB dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan yang berlaku dan berkoordinasi dengan program nasional TB;
 3. Obat anti TB disimpan di instalasi farmasi Rumah Sakit sesuai dengan standar penyimpanan obat, termasuk pengaturan suhu, keamanan, dan pemantauan tanggal kedaluwarsa;
 4. Distribusi obat kepada pasien dilakukan sesuai dengan resep dokter dan dicatat dalam sistem pencatatan farmasi Rumah Sakit;
 5. Instalasi farmasi melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak terjadi kekosongan obat anti TB.
- 10.3 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan TB MDR (bagi rumah sakit rujukan TB MDR)
1. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium yang sesuai, seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi resistensi obat;
 2. Pengobatan diberikan menggunakan regimen obat lini kedua sesuai pedoman nasional;
 3. Pelayanan TB MDR dilakukan oleh tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, petugas laboratorium, dan tenaga konseling;
 4. Pasien TB MDR dipantau secara berkala untuk menilai respons terapi serta mendeteksi efek samping obat;
 5. Rumah sakit menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan TB melalui penerapan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- 10.4 Rumah Sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus TB paru sesuai ketentuan
1. Setiap pasien TB yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit harus dicatat dalam rekam medis dan register TB;
 2. Rumah sakit wajib melaporkan kasus TB kepada dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sistem pelaporan program TB;
 3. Pelaporan dilakukan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh program nasional TB, seperti Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
 4. Tim program TB rumah sakit melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan ketepatan pelaporan kasus TB secara berkala.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman pelayanan TB dengan strategi DOTS merupakan bahan rujukan bagi pimpinan rumah sakit dalam rangka pelayanan TB, juga sebagai bahan rujukan akreditasi rumah sakit. Keberhasilan pelaksanaan strategi DOTS di rumah sakit sangat bergantung pada komitmen dan kemampuan para penyelenggara pelayanan kesehatan serta dukungan stake holder terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan adanya pedoman ini, seluruh anggota Tim Pelayanan Geriatri dan unit terkait di rumah sakit diharapkan dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional, terintegrasi, serta sesuai dengan standar pelayanan, standar akreditasi rumah sakit, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta peningkatan mutu pelayanan geriatri secara berkelanjutan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan evaluasi serta peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pelayanan, serta perubahan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pelayanan geriatri di rumah sakit dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup pasien geriatri, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Demikian pedoman pelayanan TB Rumah Sakit ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kes